A. PREAMBULE 1

B. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS AU 1ER TRIMESTRE 1

C. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS AU 2EME TRIMESTRE 2

A. PRÉAMBULE

Zones de normalité recommandées par le groupe ABA (Association des Biologistes Agréés) pour les marqueurs sériques maternels du dépistage de la Trisomie 21

Marqueurs sériques maternels	Trimestre de dépistage	Valeur basse ↘	**Valeur normale N**	Valeur élevée ↗
AFP	T2	Si < 0.25 MoM	**De 0.25 à 2.50 MoM**	Si > 2.50 MoM
βhCG ou hCG	T1 et T2	Si < 0.25 MoM	**De 0.25 à 5.0 MoM**	Si > 5.0 MoM
PAPP-A	T1	Si < 0.25 MoM	**De 0.25 à 2.50 MoM**	Si > 2.50 MoM

En cas de PAPP-A < 0.25 MoM ou d'hCG > 5 MoM, le risque de T21 sera minimisé par le bornage du logiciel.

B. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS AU 1ER TRIMESTRE

D'après la fédération des CPDPN

PAPP-A	βhCG ou hCG	Etiologies possibles	Conduite à tenir
↘ **< 0.20 MoM isolée**	**N**	- Anomalie chromosomique fœtale (T21, T18, triploïdie) - FC ou MFIU	Echographie intermédiaire* vers 18SA
↗ **> 2.5 MoM isolée**	**N**	- Pas de pathologie décrite	Rassurer la patiente
N	↘ **< 0.25 MoM**	- **MFIU précoce++** - Anomalie chromosomique fœtale (T18, triploïdie)	Contrôle de la vitalité fœtale Echographie intermédiaire* vers 18SA
N	↗ **Entre 5 et 10 MoM**	- Anomalie chromosomique fœtale - Insuffisance rénale maternelle - Prééclampsie maternelle, HTA, pathologie placentaire +++	Echographie intermédiaire* vers 18SA
N	↗↗ **> 10 MoM**	- Anomalie chromosomique fœtale - Choriocarcinome - Tumeur ovarienne - Triploidie	Echographie de référence et avis CPDPN Demander un nouveau dosage des HCG avec cinétique en MoM à 2 mois d'intervalle. Contrôle des ovaires et de l'aspect placentaire (triploïdie). Si persistance, demander un contrôle en post-partum.

↘ **< 0.25 MoM**	↗↗ **> 10 MoM**	- **Anomalie chromosomique fœtale (risque T21 +++)**	Echographie intermédiaire* vers 18SA
↗ **> 2.50 MoM**	↗↗ **> 10 MoM**	- **Prééclampsie maternelle, HTA, pathologie placentaire +++**	Echographie intermédiaire* vers 18SA
↗ **> 2.50 MoM**	↗ **> 2.50 MoM**	- Grossesse gémellaire (jumeau évanescent)	Marqueurs du 2ème trimestre Echo intermédiaire* vers 18SA
↘ **< 0.25 MoM**	↘ **< 0.25 MoM**	- Risque de T18 - Pathologies syndromiques	Echographie de référence et indication large de prélèvement invasif à discuter en CPDPN

C. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS AU 2EME TRIMESTRE

AFP	βhCG ou hCG	Etiologies possibles	Conduite à tenir
↗ **> 2.5 MoM isolée**	**N**	- Saignements fœto-maternels (80%) - Défaut de fermeture du tube neural - Défaut de fermeture de la paroi abdominale (laparoschisis) - Jumeau évanescent - Autres étiologies rares	Echographie intermédiaire* vers 18SA
↗ **> 2.5 MoM**	↗ **> 2.50 MoM**	- Pathologie placentaire, RCIU, MFIU - Grossesse gémellaire	Echographie intermédiaire* vers 18SA
↘ **< 0.25 MoM**	↘ **< 0.25 MoM**	- Anomalie chromosomique fœtale (T21, T18, triploïdie) - FC ou MFIU	Echographie intermédiaire* vers 18SA

***L'échographie intermédiaire vers 18SA devra être effectuée par un échographiste travaillant avec un CPDPN ou appartenant à un CPDPN.**
Plus d'informations sur le site du CPDPN : http://www.chu-st-etienne.fr/Reseaux/CPDPN/Accueil.asp

Pour les laboratoires, il est souhaitable dans les situations suscitées que soit indiqué : « valeur basse, une échographie est souhaitable » ou les termes : « échographie de contrôle », « échographie de référence », « échographie spécialisée », « échographie détaillée » plutôt que « valeur effondrée » qui inquiète les patientes ou le nom de maladie (trisomie 18 par exemple).

Sources	- Test ADNlc T21 : les indications « à la marge » - Réflexions Fédération des CPDPN - CMF 2019 - Geyl C , Subtil D, Vaast P, Coulon C, Clouqueur E, Deruelle P, Debarge V : Interpretation des valeurs atypiques des marqueurs sériques maternels, J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2014 Jan;43(1):5-11 - Muller F, et al : Dépistage de la trisomie 21 par les marqueurs sériques maternels, justification des commentaires appliqués par les biologistes, J gynecol obstet Biol reprod(Paris) . 2014
Rédaction et Validation RP LNA – 1	Dr Tiphaine BARJAT – Gynécologue-obstétricien Mme Stéphanie WEISS – Sage-femme coordinatrice ELENA
Actualisation RP LNA – 2 et 3	Dr Tiphaine BARJAT – Gynécologue-obstétricien Dr Fabienne PRIEUR – Généticien coordonnateur CPDPN Saint-Etienne Mme Aurélie DELMAS – Infirmière coordinatrice ELENA